

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文 献监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-05-31 至 2026-06-06。每篇文章单独成页，按“标题、结论、主要内容、关键信息、启示”快速浏览；启示严格区分已验证证据、作者观点和我的推断。

EDAT 新入库 42	PDAT 发表日期 65	MDAT 记录更新 212	精选入页 10
----------------	-----------------	------------------	------------

固定公网主页：<https://zhengyipharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch；窗口为 2026-05-31 至 2026-06-06，合并 EDAT、PDAT、MDAT 以覆盖近 7 天新增入库、发表日期和记录更新。今日精选优先保留 6 月 5 日固定页未收录过的高相关 DLBCL/CNSL 治疗、机制、转化、安全性与真实世界文献；旧发表但 MDAT 命中的条目标注为近 7 天记录更新或近期高相关参考。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

覆盖方向：BTKi、双抗、CAR-T/细胞治疗、ADC、免疫治疗、靶向联合、病例/病例系列、基础/机制/转化、耐药、CNS 穿透/药代、安全性和真实世界。

#	方向	疾病	PMID	标题
1	ADC / 系统综述	R/R DLBCL	42244006	Loncastuximab tesirine 单药治疗 R/R DLBCL 的系统综述与荟萃分析
2	PCNSL / CSF 分子与免疫标志物	PCNSL / secondary CNS lymphoma	42242260	PRICELUS: CSF 中 MYD88、IL-10、CXCL13 用于 CNS 淋巴瘤诊断的前瞻队列
3	多组学 / 高危分层	DLBCL	42242231	Cancer Cell: 478 例 DLBCL 多组学整合定义 7 类 proteogenotype
4	耐药机制 / m6A 修饰	double-expressor DLBCL	42242087	METTL3 通过 β -catenin/MYC 轴促进 double-expressor DLBCL 利妥昔单抗耐药
5	单细胞/空间组学 / 微环境	DLBCL	42247321	CD3+ 肿瘤性 B 细胞通过 TGF- β 相关轴重塑 DLBCL 微环境
6	预后模型 / LLPS	DLBCL	42246608	机器学习构建 DLBCL 液-液相分离相关 6 基因预后模型
7	药物再利用 / 转化机制	DLBCL	42235267	整合 in silico 与体外实验筛选 DLBCL 潜在再利用联合药物
8	细胞治疗 / 靶点策略综述	LBCL / B-cell malignancies	42233022	从 CAR-T 到 CAAR-T: B 细胞恶性肿瘤的 idiotype-directed 细胞治疗假设
9	CAR-T / 安全性真实世界	R/R DLBCL / FL	42173255	CD19 CAR-T 后 prolonged CRS 与低纤维蛋白原血症相关
10	BTKi 联合 / I 期临床	R/R DLBCL	41824782	Zanubrutinib + lenalidomide 治疗 R/R DLBCL 的 I 期多中心研究

Loncastuximab tesirine 单药治疗 R/R DLBCL 的系统综述与荟萃分析

Efficacy and safety of loncastuximab tesirine in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma: a systematic review and meta-analysis.

ADC / 系统综述 R/R DLBCL EDAT/PDAT/MDAT 窗口内：PubMed 2026-06-05 新入库

P 复发/难治 DLBCL，尤其是不适合移植或 CAR-T 的重度经治患者

I Loncastuximab tesirine 单药

C 不同研究队列的历史或观察性对照；荟萃分析按研究类型分层

O ORR、CR、1 年 OS/PFS、治疗相关不良事件

结论

该荟萃分析汇总 7 项研究，提示 loncastuximab tesirine 单药在重度经治 R/R DLBCL 中具有约 47% ORR 和约 22% CR，但 3 级及以上不良事件负担较高。

主要内容

- 纳入 3 项临床试验和 4 项观察队列，按 PRISMA 2020 流程评价 loncastuximab tesirine 单药。
- 合并 ORR 为 47.3%，CR 为 22.0%；1 年 OS 为 48.2%，1 年 PFS 为 31.2%。
- 临床试验亚组 ORR 47.3%，CR 23.9%，1 年 OS 43.8%，1 年 PFS 28.0%。
- 任意治疗相关不良事件发生率 98.7%，3 级及以上事件 82.6%，常见血液学毒性包括中性粒、白细胞、血小板和贫血事件。

关键信息

- ADC 方向今日最直接的新治疗证据汇总。
- 疗效信号需要与高等级毒性、患者选择和序贯策略一起解读。
- 作者明确提出仍需要随机研究优化患者选择和治疗排序。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认纳入 7 项研究、ORR/CR/OS/PFS 合并结果以及高等级不良事件比例。

论文作者观点

作者认为 loncastuximab tesirine 可作为选择有限 R/R DLBCL 患者的有价值选择，并强调需要随机研究优化选择和排序。

我的推断

后续真实世界或序贯研究应把前线 CAR-T/双抗暴露史、骨髓储备和水肿/皮疹等毒性管理作为预设分层；这只是研究设计启示，不构成治疗推荐。

PRICELUS: CSF 中 MYD88、IL-10、CXCL13 用于 CNS 淋巴瘤诊断的前瞻队列

Diagnosis of primary CNS lymphoma through molecular and immune biomarkers in cerebrospinal fluid (PRICELUS): a multicentre, prospective, cohort study.

PCNSL / CSF 分子与免疫标志物

PCNSL / secondary CNS lymphoma

EDAT/PDAT/MDAT 窗口内: PubMed 2026-06-05 新入库

P 疑似 primary CNS lymphoma、接受 CSF 分析的成人患者

I CSF MYD88 L265P、IL-10、CXCL13 联合检测

C 最终临床诊断与常规诊断路径

O 敏感性、特异性、阴性预测值和潜在非侵入性诊断支持

结论

在疑似 PCNSL 的多中心前瞻队列中，MYD88 L265P、IL-10 和 CXCL13 组合显示较高诊断价值，三者全阴性时阴性预测值达 99.4%，但算法仍需外部验证。

主要内容

- 荷兰 5 家医院纳入 255 例疑似 PCNSL 且接受 CSF 分析的成人患者。
- 50 例最终诊断为 CNS lymphoma，其中 44 例为 PCNSL，6 例为 secondary CNS lymphoma。
- CSF MYD88 检出敏感性 56.0%，特异性 98.5%。
- MYD88 阳性且 IL-10 或 CXCL13 升高时，特异性达到 100.0%；三项均阴性时 NPV 为 99.4%。

关键信息

- 这是 CNSL 诊断路径的高相关前瞻性证据，不是治疗疗效研究。
- 价值在于减少活检依赖和缩短诊断延迟的潜在路径。
- 作者提醒诊断树和算法在同一队列中产生，需谨慎解释。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认队列规模、CNS lymphoma 病例数、MYD88/IL-10/CXCL13 组合表现和 99.4% 阴性预测值。

论文作者观点

作者认为联合 CSF biomarker 在特定场景中可能支持非侵入性诊断决策，并可能减少对脑活检的依赖。

我的推断

CNSL 治疗研究可把 CSF 分子/免疫标志物纳入入组确认、疗效监测和分层字段，但不能把该算法直接当作已验证的独立诊断标准。

Cancer Cell: 478 例 DLBCL 多组学整合定义 7 类 proteogenotype

Pathogenesis of diffuse large B cell lymphoma proteogenotypes.

多组学 / 高危分层 DLBCL EDAT/PDAT/MDAT 窗口内: PubMed 2026-06-05 新入库

P DLBCL 肿瘤样本队列

T 蛋白组、转录组、基因组整合分型

C 传统 COO、IPI 与遗传特征分层

O proteogenotype、PG4 高危识别、MYC/TCF 活性与免疫微环境特征

结论

研究整合蛋白组、转录组和基因组数据，提出 7 类 DLBCL proteogenotype；其中 PG4 独立于 COO、IPI 和遗传特征预测不良结局，并与 MYC/TCF 活性和耗竭 CD8+T 细胞微环境相关。

主要内容

- 分析 478 个 DLBCL 肿瘤，整合 proteomic、transcriptomic 和 genomic 数据。
- 识别 7 个反映不同病理生理特征的 proteogenotype。
- PG4 与不良预后相关，独立于 cell-of-origin、IPI 和既有遗传特征。
- PG4 同时包含 ABC-like、GCB-like 和遗传未分类病例，呈现 dark-zone-like 表型、BTG1 突变富集、MYC 与 TCF3/4 活性增强，以及 CD8+T 细胞耗竭。

关键信息

- 这篇文章把 DLBCL 风险分层从基因/转录推向蛋白组整合。
- PG4 可能解释一部分传统 COO 或 IPI 难以捕捉的高危人群。
- 对新治疗研究的启示集中在高危富集、微环境指标和 MYC 轴干预假设。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认 478 例样本、7 类 proteogenotype、PG4 的独立预后价值和 MYC/TCF/CD8 耗竭特征。

论文作者观点

作者认为该 proteogenomic 框架可支持未来诊断和治疗策略。

我的推断

未来 DLBCL 方案设计可探索把 proteogenotype 或其简化 surrogate 作为前瞻分层变量；目前仍属于转化研究假设，不能替代临床风险模型。

METTL3 通过 β -catenin/MYC 轴促进 double-expressor DLBCL 利妥昔单抗耐药

Mechanism of METTL3 promoting rituximab resistance via β -catenin/MYC axis in double-expressor diffuse large B cell lymphoma.

耐药机制 / m6A 修饰 double-expressor DLBCL EDAT/MDAT 窗口内：PubMed 2026-06-05 新入库

P double-expressor DLBCL 细胞和小鼠模型

I METTL3 knockdown 或 STM2457，联合/对照 RTX 暴露

C METTL3 高表达或未抑制状态

O 细胞周期、增殖、RTX resistance、肿瘤生长和 β -catenin/MYC/BCL2 轴变化

结论

研究提示 METTL3 可通过 YTHDF2 介导的 m6A 修饰稳定 β -catenin，间接激活 MYC/BCL2 转录并增强利妥昔单抗耐药；METTL3 抑制在小鼠模型中削弱肿瘤生长和耐药。

主要内容

- 体外使用 U-2932 double-expressor DLBCL 细胞，并进行 METTL3 敲低、 β -catenin/MYC/BCL2 操作和利妥昔单抗处理。
- METTL3 上调与细胞周期推进、增殖增强和 RTX resistance 相关。
- 机制链条为 METTL3 m6A 修饰 β -catenin，经 YTHDF2 影响稳定性，进而激活 MYC/BCL2。
- 在 DE-DLBCL 裸鼠模型中，METTL3 抑制剂 STM2457 联合 RTX 抑制肿瘤生长和耐药表型。

关键信息

- 聚焦 double-expressor DLBCL 的抗 CD20 耐药机制。
- 把表观转录组 m6A、 β -catenin、MYC/BCL2 串成可实验验证的轴。
- 仍是机制研究，不能外推为临床联合方案证据。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认 METTL3、 β -catenin/MYC/BCL2、RTX resistance 和体内 STM2457 实验结果。

论文作者观点

作者认为 METTL3/ β -catenin/MYC 轴揭示了淋巴瘤间接转录调控和潜在治疗靶点。

我的推断

抗 CD20 相关研究可预设 METTL3/m6A 或 MYC/BCL2 相关分层，尤其用于解释 double-expressor 人群的耐药异质性；这属于方案设计启示。

CD3+ 肿瘤性 B 细胞通过 TGF-β 相关轴重塑 DLBCL 微环境

Neoplastic CD3+ B cells remodel the DLBCL tumor microenvironment via single-cell and spatial transcriptomics.

单细胞/空间组学 / 微环境 DLBCL EDAT/PDAT/MDAT 窗口内：PubMed 2026-06-05 新入库；期刊卷期日期为 2026 Dec 31

P DLBCL 肿瘤样本及其微环境细胞图谱

I 单细胞、单核与空间转录组整合识别 CD3+ malignant B cell subset

C 无该细胞群或丰度较低的 DLBCL 微环境

O M2 巨噬细胞富集、TGF-β 信号、治疗反应和生存关联

结论

研究通过单细胞、单核和空间转录组发现一个异常表达 CD3 的肿瘤性 B 细胞群，该群与巨噬细胞富集、M2 极化、TGF-β 信号和不良临床结局相关。

主要内容

- 构建 DLBCL 高分辨率多组学图谱，整合 single-cell、single-nucleus 和 spatial transcriptomics。
- 识别 CD3+ malignant B cell subset，可能由 BCLAF1、CHURC1、FLI1、NFATC2、ELF2 调控环路驱动。
- 空间和功能分析提示该细胞群与 macrophage enrichment、M2 polarization 和 TGF-β signaling 相关。
- CD3+ B 细胞丰度与更晚期疾病、较差治疗反应和较短生存相关。

关键信息

- 这是微环境重塑和异常表型 B 细胞的新机制线索。
- 临床相关性来自关联分析，仍需功能干预和独立队列验证。
- 与昨日 TNFRSF1A+ macrophage 信号形成微环境主题延续。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认 CD3+ 肿瘤 B 细胞、5 基因调控环路、M2/TGF-β 关联和预后关联。

论文作者观点

作者认为该 CD3+ B 细胞群及 FLI1、TGF-β 轴可能代表潜在治疗靶点。

我的推断

未来 DLBCL 免疫治疗或微环境干预研究可考虑把异常 B 细胞表型和 macrophage/TGF-β 读数作为探索性 biomarker；目前不能把 CD3+ B 细胞当作已验证用药决策依据。

机器学习构建 DLBCL 液-液相分离相关 6 基因预后模型

Machine learning-driven investigation on liquid-liquid phase separation-related prognostic signature in diffuse large B-cell lymphoma.

预后模型 / LLPS DLBCL EDAT/PDAT/MDAT 窗口内：PubMed 2026-06-05 新入库

P 公开和队列转录组中的 DLBCL 患者

I 机器学习筛选并构建 LLPS 相关 6 基因模型

C 既有临床变量和未分层人群

O OS 风险分层、AUC、独立预后价值和免疫微环境差异

结论

研究基于 4 个队列 768 例转录组和临床数据，构建 LLPS 相关 6 基因预后模型，可在多个数据集中区分 OS 风险，但仍需大样本前瞻验证。

主要内容

- 使用 multiple machine learning algorithms 筛选 LLPS-related prognostic genes。
- 构建 6-LRG model 并进行 survival analysis、time-dependent ROC 和 multivariable modelling。
- 模型 1 年 AUC 为 0.661-0.820，3 年 AUC 为 0.683-0.779，5 年 AUC 为 0.711-0.807。
- 模型独立于已建立临床变量，并可与 nomogram 结合；不同风险组显示生物学和免疫微环境差异。

关键信息

- 不是治疗试验，而是风险分层与生物学假设生成研究。
- LLPS 可能连接转录调控、微环境和 DLBCL 异质性。
- 作者明确要求 prospective validation，不能直接临床实施。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认 4 队列 768 例、6-LRG 模型、AUC 范围和独立预后信息。

论文作者观点

作者认为该模型可能提供额外预后信息，并生成关于潜在生物机制的假设。

我的推断

新治疗研究可把 LLPS signature 作为探索性分层或伴随生物学分析，但不应在未验证前用于患者选择。

整合 in silico 与体外实验筛选 DLBCL 潜在再利用联合药物

Synergistic drug repurposing strategy identifies doxorubicin and paclitaxel as potential combination therapy for diffuse large B-cell lymphoma.

药物再利用 / 转化机制 DLBCL PDAT/MDAT 窗口内: PubMed 2026-06-04 新入库

P DLBCL 相关基因集和 2PK-3 DLBCL 细胞

I Doxorubicin + paclitaxel 联合暴露

C 单药暴露和计算筛选候选药物

O 细胞活性、形态学损伤、ROS 生成和候选通路

结论

研究通过网络药理、分子 docking 与 2PK-3 DLBCL 细胞实验，提出 doxorubicin 与 paclitaxel 联合在体外显示增强细胞毒性和 ROS 生成。

主要内容

- 从 DisGeNET 与 GeneCards 获得 DLBCL 相关基因并识别 144 个重叠基因。
- 富集分析突出 PI3K-Akt、apoptosis 和 cell cycle regulation。
- 筛选 AKT1、TP53、MYC、STAT3 等核心靶点，并从 DSigDB/DrugMAP 进行候选药物筛选。
- 体外 MTT、形态学和 ROS 实验证实 doxorubicin + paclitaxel 较单药增强细胞毒性。

关键信息

- 属于早期转化和体外证据，不能等同于临床组合方案。
- 价值在于提出 TP53/MYC/STAT3/PI3K-Akt 相关脆弱性。
- 需要动物模型、剂量安全性和临床可行性进一步验证。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认 144 个重叠基因、PI3K-Akt/凋亡/细胞周期富集、候选靶点和 2PK-3 体外实验结果。

论文作者观点

作者认为 doxorubicin 与 paclitaxel 具有作为 DLBCL 药物再利用联合策略的潜力。

我的推断

该文适合作为耐药机制和药物再利用假设来源，而不是直接推动临床用药；后续设计应先补足体内和毒性窗口。

从 CAR-T 到 CAAR-T：B 细胞恶性肿瘤的 idiotype-directed 细胞治疗假设

From CAR-T to CAAR-T: redefining targeting strategies in B-cell malignancies through idiotype-directed cellular therapy.

细胞治疗 / 靶点策略综述

LBCL / B-cell malignancies

EDAT/MDAT 窗口内：PubMed 2026-06-03 入库，2026-06-05 Medline 更新

P B 细胞恶性肿瘤，尤其包括 R/R large B-cell lymphoma

I Idiotype-directed CAAR-T 概念平台

C 以 CD19/BCMA 等 lineage antigen 为靶点的传统 CAR-T

O 选择性、on-target/off-tumor toxicity、制造/监管障碍和验证需求

结论

综述认为 CAAR-T 以疾病定义性免疫球蛋白结构或 BCR idiotype 为靶点，理论上可能提高选择性，但在 B 细胞恶性肿瘤中仍主要是需要严格验证的假设平台。

主要内容

- 作者回顾 CAR-T 在 R/R LBCL 等血液肿瘤中的变革性作用及其局限。
- 局限包括 B-cell aplasia、低丙种球蛋白血症、感染、长期免疫功能异常、CRS、ICANS、血液毒性、制造复杂性和疗效异质性。
- CAAR-T 设计思想是识别 surface immunoglobulin 或 BCR idiotype 等 clonotypic structures。
- 作者强调该策略在自身免疫病中探索更多，在 B 细胞恶性肿瘤中不应被视为近期替代 approved CAR-T。

关键信息

- 这是细胞治疗靶点选择的概念性前沿综述。
- 对 DLBCL/LBCL 的直接临床证据有限，重点在平台设计边界。
- 可作为下一代细胞治疗抗原选择、制造和监管讨论的参考。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认 CAAR-T 的 idiotype/BCR 靶向概念、CAR-T 局限和作者对验证需求的界定。

论文作者观点

作者认为 CAAR-T 不应被看作近期替代 CAR-T，而是需要疾病特异性严格验证的 precision platform。

我的推断

DLBCL 细胞治疗研究可借鉴 idiotype-directed 的选择性逻辑，但近期更现实的方向仍是抗原逃逸、毒性降低和制造可及性优化。

CD19 CAR-T 后 prolonged CRS 与低纤维蛋白原血症相关

Prolonged Cytokine Release Syndrome is Associated with Hypofibrinogenemia after CD19-Directed CAR T-Cell Therapy in Adult Patients with Relapsed/Refractory Lymphoma.

CAR-T / 安全性真实世界

R/R DLBCL / FL

MDAT 窗口内：近 7 天记录更新，作为安全性高相关参考

P

接受 CD19 CAR-T 的成人 R/R DLBCL 或 FL 患者

I

按 CRS 持续时间、基线纤维蛋白原和 CAR-T 产品类型进行风险分析

C

无 prolonged CRS、不同产品或较高基线纤维蛋白原患者

O

30 天内低纤维蛋白原血症、FFP 使用、出血和生存结局

结论 单中心真实世界队列显示，CD19 CAR-T 后 30 天内低纤维蛋白原血症发生率为 25%；prolonged CRS、较低基线纤维蛋白原和 axi-cel 使用与风险独立相关。	主要内容 - 纳入京都大学医院 2019-2024 年连续成人 R/R DLBCL 或 FL 患者 111 例。 - 治疗产品包括 tisa-cel 74 例、liso-cel 24 例、axi-cel 13 例。 - 低纤维蛋白原血症定义为 fibrinogen <=150 mg/dL，30 天内发生 28 例，发生率 25%，中位发生时间 10.5 天。 - 多变量分析显示 grade >=1b CRS、低基线纤维蛋白原和 axi-cel 使用与低纤维蛋白原血症独立相关；队列中未发生致死性出血。
---	---

关键信息

- 安全性焦点从典型 CRS/ICANS 扩展到凝血和支持治疗监测。
- grade 1b prolonged CRS 被单独定义，有助于捕捉低级别但持续的炎症负荷。
- 结果来自单中心回顾队列，需多中心验证。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认 111 例队列、25% 低纤维蛋白原血症、风险因素和无致死性出血。

论文作者观点

作者认为风险适配的 fibrinogen monitoring 可能帮助识别需要更密切监测和及时替代支持的患者。

我的推断

CAR-T 真实世界研究应记录 CRS 持续时间、基线凝血指标和产品类型，而不只记录 CRS 最高级别；这属于安全性研究设计启示。

Zanubrutinib + lenalidomide 治疗 R/R DLBCL 的 I 期多中心研究

Phase 1 study of zanubrutinib plus lenalidomide for patients with relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma.

BTKi 联合 / I 期临床 R/R DLBCL MDAT 窗口内：近 7 天记录更新，期刊日期为 2026 Jun 09

P R/R DLBCL，多数为晚期且 non-GCB/ABC-like 人群

I Zanubrutinib 160 mg bid + lenalidomide 剂量递增/扩展

C 不同 lenalidomide 剂量层级和历史预期疗效

O RP2D、ORR、CR、DOR、PFS 和治疗相关毒性

结论

I 期 BGB-3111-110 研究中，zanubrutinib 160 mg bid 联合 lenalidomide 的推荐剂量为 25 mg qd；RP2D 下 ORR 58%、CR 42%，但 3 级及以上不良事件发生率 74%。

主要内容

- 66 例 R/R DLBCL 接受 zanubrutinib 160 mg twice daily 加 lenalidomide 15/20/25 mg once daily。
- 患者中位既往治疗 2 线，83% 为 III/IV 期，约 67% 为 non-GCB 或 ABC-like DLBCL。
- 未发生剂量限制性毒性；lenalidomide RP2D 为 25 mg qd，与 zanubrutinib 160 mg bid 联合。
- RP2D 下 ORR 58%、CR 42%；中位 DOR 14.9 个月，中位 PFS 5.5 个月；3 级及以上 TEAE 74%，最常见为中性粒和白细胞减少。

关键信息

- BTKi 联合免疫调节剂方向仍有 R/R DLBCL 临床探索价值。
- 疗效信号需结合短 PFS 和骨髓抑制负担解读。
- 该研究更适合支持后续分层研究，而不是直接改变治疗路径。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认 66 例 I 期研究、RP2D、ORR/CR、DOR/PFS 和 3 级及以上 TEAE。

论文作者观点

作者认为 zanubrutinib + lenalidomide 在 R/R DLBCL 中显示可接受耐受性和抗肿瘤活性。

我的推断

后续 BTKi 联合研究应优先围绕 non-GCB/ABC-like、BCR/NF-κB 依赖和骨髓毒性风险做分层；这里不能解读为普遍推荐联合使用。

今天的信号不是单一药物热点，而是“疗效前移 + 治疗可及 + CNS/微环境分层 + 安全管理”同步推进

已验证证据 本轮 PubMed 官方窗口命中 EDAT 42 条、PDAT 65 条、MDAT 212 条，三者去重后 227 条候选；今日精选 10 篇，均未重复 2026-06-05 固定页已收录 PMID。	论文作者观点 今日多篇作者观点共同指向：R/R DLBCL 的 ADC、BTKi 联合和细胞治疗需要更清晰的患者选择、毒性管理与序贯策略；CNSL 方向正在把 CSF 分子标志物、CNS 穿透和非侵入性诊断前移。	我的推断 今天的主要信号不是单个药物突破，而是“治疗选择变多后，分层、序贯、安全性和 CNS 专属监测必须一起设计”。后续 slides 应持续优先跟踪前瞻验证、真实世界可及性、CNS/CSF 读数和机制分层，不生成治疗推荐。
下一次优先跟进 继续观察 frontMIND OS/ctDNA、PCNSL 双抗 CNS 穿透验证、双抗治疗中 PET 动态指标、CAR-T 可及性和桥接前 MTV 变化。	设计启示 DLBCL/CNSL 研究应同时记录疗效、到达治疗的路径、CNS/CSF 指标、影像负荷、分子/微环境分层和感染/神经毒性安全窗口。	边界提醒 本页仅作文献监测、证据摘要和方案设计启示整理，不提供医疗建议，也不生成治疗推荐。